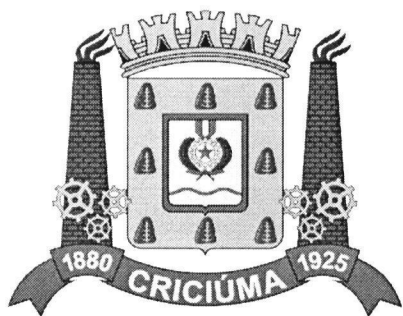


NUTRICIONISTA



Município de Criciúma/SC

Processo Seletivo Simplificado 01/2026

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA



3 horas



40 questões



4 alternativas



Saída permitida somente após
1 hora e 30 minutos de prova



O candidato só poderá
levar este Caderno nos
últimos 30 minutos para
o término da prova

INSTRUÇÕES



Confira se esse Caderno de Prova contém a quantidade de questões indicadas. A substituição deste Caderno de Prova ocorre apenas antes de iniciar a prova.

- ▣ O tempo de prova inclui o preenchimento do Cartão-Resposta.
- ▣ Nenhuma informação acerca do conteúdo das questões será fornecida pelo Fiscal de Sala, pois é parte integrante da prova.
- ▣ Antes de sair da Sala de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal de Sala, **devidamente assinado**, e, após, se desloque imediatamente para a saída do local de prova.
- ▣ Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na Sala de Prova até que o último termine a sua prova, devendo ambos testemunhar a devolução e o lacre dos documentos.
- ▣ A divulgação do gabarito preliminar se dará conforme Cronograma de Execução do certame.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS AO INSTITUTO LEGALLE. PROIBIDO REPRODUÇÃO.

RASCUNHO PARA GABARITO

01		06		11		16		21		26		31		36	
02		07		12		17		22		27		32		37	
03		08		13		18		23		28		33		38	
04		09		14		19		24		29		34		39	
05		10		15		20		25		30		35		40	

Para responder às questões 01 a 05, leia o texto abaixo.

Dia Mundial da Saúde: UNICEF destaca avanços do Brasil e reforça a importância de seguir investindo na saúde infantil

No Dia Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) destaca os avanços significativos conquistados pelo Brasil nas últimas décadas na promoção da saúde de crianças e adolescentes.

O País alcançou resultados históricos na redução da mortalidade infantil, em consonância com a tendência global. Dados mostram que o Brasil registrou, em 2024, as menores taxas de mortalidade neonatal e de crianças menores de cinco anos dos últimos 34 anos.

Outro marco relevante foi a saída do Brasil do Mapa da Fome. O resultado, que considera a média trienal de 2022, 2023 e 2024, colocou o País abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso regular a alimentos suficientes.

O Brasil também tem apresentado queda consistente na gravidez na adolescência. Em 2019, 14,7% dos nascimentos eram de mães adolescentes; em 2024, esse percentual caiu para 11,4%.

Na área da imunização, o País vive um cenário de retomada, mas esforços são necessários. Em 2024 e 2025, 15 das 16 principais vacinas infantis apresentaram aumento de cobertura. Ainda assim, apenas vacinas como BCG e Hepatite B atingiram a meta de 95% em 2025. Além disso, em 2024, embora 2,3 milhões de crianças tenham recebido a primeira dose da vacina DPT, cerca de 229 mil não tomaram nenhuma dose.

“Neste Dia Mundial da Saúde, o UNICEF celebra os avanços conquistados pelo Brasil, que mostram que políticas públicas funcionam e salvam vidas. Ao mesmo tempo, lembramos que ainda há meninas e meninos sem acesso pleno à vacinação, à nutrição adequada e ao cuidado integral. Garantir a saúde de crianças e adolescentes é investir no presente e no futuro do País e isso exige compromisso contínuo”, afirma a chefe de Saúde e Nutrição do UNICEF no Brasil.

Adaptado de: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-impressao/dia-mundial-da-saude-unicef-destaca-avancos-do-brasil-e-reforca-importancia-de-seguir-investindo-na-saude-infantil>

Questão 01. A recorrência de dados estatísticos no desenvolvimento do texto cumpre, sobretudo, a função de:

- (A) Atribuir maior grau de objetividade e legitimidade às informações, reforçando a credibilidade do discurso.
- (B) Relativizar a autoridade institucional do UNICEF ao priorizar dados em detrimento de posicionamentos.
- (C) Conferir excessiva tecnicidade ao texto, comprometendo sua acessibilidade ao leitor médio.
- (D) Substituir o encadeamento argumentativo por uma exposição meramente quantitativa.

Questão 02. Considerando as informações explícitas e implícitas no texto, bem como a relação entre dados apresentados e a interpretação global do conteúdo, analise as assertivas a seguir:

- I. O cenário da imunização é descrito como em recuperação, embora ainda aquém das metas ideais.
- II. O texto sugere que políticas públicas têm impacto direto na melhoria das condições de saúde.
- III. A saída do Mapa da Fome significa que não há mais insegurança alimentar no Brasil.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 03. Considerando a classificação morfológica e o valor semântico de vocábulos do texto, bem como seu funcionamento no contexto das frases, analise as partes que seguem:

(1ª parte): Na frase **O País alcançou resultados históricos na redução da mortalidade infantil**, a palavra **históricos** consiste em um adjetivo de natureza qualificativa, atribuindo valor aos resultados mencionados.

(2ª parte): Na frase **O Brasil também tem apresentado queda consistente na gravidez na adolescência**, o vocábulo **também** classifica-se como conjunção coordenativa aditiva.

Pode-se afirmar que:

- (A) Ambas as partes estão corretas.
- (B) Apenas a 1ª parte está correta.
- (C) Apenas a 2ª parte está correta.
- (D) Ambas as partes estão incorretas.

Questão 04. Com base na análise gramatical e fonológica de elementos do texto, analise as assertivas que seguem, julgando-as V, se Verdadeiras, ou F, se Falsas:

- () Em **lembramos que ainda há meninas e meninos sem acesso pleno à vacinação**, a palavra **ainda** é classificada, gramaticalmente, como pronome.
- () Os substantivos **saúde** e **vacinação** apresentam o mesmo processo de formação de plural.
- () A palavra **taxas** possui cinco fonemas; a palavra **nascimentos** possui nove fonemas.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) F – F – F.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.

Questão 05. Considerando a organização das ideias, os recursos argumentativos e a progressão temática do texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O texto apresenta uma progressão temática baseada principalmente em oposição entre dados estatísticos.
- (B) O final do texto amplia a discussão ao relacionar saúde infantil com desenvolvimento social e futuro do país.
- (C) A informação sobre crianças sem dose da DPT invalida os dados positivos apresentados anteriormente.
- (D) A redução da gravidez na adolescência é apresentada como um fenômeno episódico, destituído de continuidade ao longo do período analisado.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 06. Para pintar as paredes de um depósito retangular de 6 metros de largura por 10 metros de comprimento e 3 metros de altura, o servidor precisa calcular a área total das paredes. Sabendo que não há janelas e que a porta de entrada possui 2 metros quadrados de área que não será pintada, qual é a metragem quadrada total de superfície de parede que receberá a nova camada de tinta?

- (A) 100 m².
- (B) 94 m².
- (C) 96 m².
- (D) 214 m².

Questão 07. Um servidor verificou que o consumo de papel sulfite reduziu em 25% após a implementação plena do processo digital. Se anteriormente eram utilizadas 80 resmas de papel por mês, qual passou a ser o consumo mensal de resmas após a adoção plena do sistema, considerando que a redução percentual foi aplicada de forma direta sobre o consumo histórico médio da unidade administrativa? O servidor precisa desse dado atualizado para realizar o novo planejamento de compra de suprimentos do setor operacional.

- (A) 70 resmas.
- (B) 55 resmas.
- (C) 65 resmas.
- (D) 60 resmas.

Questão 08. A trajetória de um objeto em um teste é descrita pela função quadrática $h(t) = -5t^2 + 20t$, onde h é a altura em metros e t é o tempo em segundos. O servidor responsável pelo experimento precisa identificar em que instante de tempo o objeto atinge a sua altura máxima antes de iniciar o processo de descida para o solo. Determine o tempo exato em segundos necessário para que o objeto alcance o ponto mais alto de sua trajetória, utilizando os parâmetros de análise de funções do segundo grau apresentados.

- (A) 2 segundos.
- (B) 3 segundos.
- (C) 1 segundo.
- (D) 4 segundos.

Questão 09. Um técnico prepara uma solução diluindo um produto em água na proporção de 2 partes de produto para 13 partes de água. Se ele precisa preparar um volume total de 30 litros dessa mistura para a higienização do prédio, quantos litros de produto concentrado ele deverá utilizar exatamente para respeitar a razão estabelecida? O servidor deve garantir que a soma das partes do produto e da água resulte no volume total final exigido para a limpeza das salas e corredores da unidade administrativa pública.

- (A) 2 litros.
- (B) 8 litros.
- (C) 4 litros.
- (D) 6 litros.

Questão 10. Uma sala administrativa quadrada teve sua área ampliada em 13 metros quadrados, passando a ter uma área total de 49 metros quadrados após a reforma das paredes laterais. O servidor do setor de patrimônio precisa registrar a medida original do lado da sala antes dessa ampliação para fins de atualização da planta baixa no sistema de gestão de ativos. Qual era a medida do lado da sala quadrada, em metros, antes do início das obras de expansão que resultaram na configuração atual de espaço do ambiente?

- (A) 4 metros.
- (B) 6 metros.
- (C) 7 metros.
- (D) 5 metros.

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA CÁLCULOS

INFORMÁTICA

Questão 11. Considerando o funcionamento e a utilização de cookies em navegadores de internet, analise as partes que seguem:

(1ª parte): Cookies podem ser utilizados tanto para funcionalidades legítimas do site quanto para fins de rastreamento comportamental.

(2ª parte): A desativação de cookies não afeta o funcionamento de sessões autenticadas em sites que exigem login.

(3ª parte): O navegador pode ser configurado para bloquear ou limitar o uso de cookies por sites.

Pode-se afirmar que:

- (A) Apenas a 3ª parte está correta.
- (B) Apenas a 1ª e a 2ª partes estão corretas.
- (C) Apenas a 1ª e a 3ª partes estão corretas.
- (D) Todas as partes estão corretas.

Questão 12. Com base nos modos de exibição do Explorador de Arquivos no Windows 11 e nas informações que cada um deles disponibiliza ao usuário, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No modo **Lista**, os arquivos são apresentados com ícones pequenos, dispostos em colunas verticais.
- (B) No modo **Ícones pequenos**, o sistema exibe mais metadados do que no modo **Blocos**.
- (C) No modo **Detalhes**, é possível ordenar os arquivos de forma crescente ou decrescente com base em qualquer coluna disponível.
- (D) O modo **Conteúdo** adapta as informações exibidas de acordo com os metadados disponíveis em cada tipo de arquivo.

Questão 13. Considerando os conceitos relacionados às extensões de arquivos e sua utilização em sistemas operacionais, analise as assertivas que seguem, julgando-as V, se verdadeiras, ou F, se falsas:

- () O usuário pode modificar o programa padrão associado à abertura de arquivos de uma determinada extensão.
- () A mudança da extensão de um arquivo é suficiente para convertê-lo integralmente para outro formato.
- () A extensão de um arquivo corresponde a um sufixo nominal, normalmente precedido por ponto, que auxilia na identificação de seu tipo.

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, de cima para baixo, os parênteses acima?

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) V – V – V.

Questão 14. Um usuário está elaborando um documento no Microsoft Word contendo informações institucionais sigilosas. Com o objetivo de indicar a natureza confidencial do conteúdo, ele insere, ao fundo de todas as páginas, um texto semitransparente com a expressão "CONFIDENCIAL", disposto de forma diagonal e visível por trás do texto principal, sem interferir na leitura. Esse elemento é aplicado de maneira uniforme em todas as páginas do documento e pode ser facilmente ativado ou removido por meio de um recurso específico da guia de design do programa. Diante dessa situação, assinale a alternativa que indica, CORRETAMENTE, o recurso utilizado pelo usuário.

- (A) SmartArt.
- (B) Marca d'água.
- (C) Folha de Rosto.
- (D) Referência Cruzada.

Questão 15. No contexto da segurança da informação, diferentes mecanismos e práticas são adotados para proteger sistemas, redes e dados contra ameaças digitais. Considerando esse cenário, analise as assertivas a seguir:

- I. A instalação de um antivírus elimina completamente a necessidade de atualizações do sistema operacional.
- II. Firewalls atuam no controle do tráfego de rede, podendo bloquear conexões não autorizadas.
- III. Conexões seguras podem ser identificadas pelo uso do protocolo HTTPS, que utiliza criptografia para proteger os dados transmitidos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/SUS

Questão 16. Considerando as recomendações vigentes para registro de dados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), a alternativa que apresenta uma combinação adequada entre fase do curso da vida e índices/parâmetros antropométricos utilizados é:

- (A) Crianças menores de 5 anos: IMC para idade, peso para idade e perímetro da cintura; adultos: IMC para idade e perímetro da panturrilha; idosos: apenas estatura para idade.
- (B) Idosos (60 anos ou mais): IMC para idade e perímetro da cintura; gestantes: peso para idade gestacional e perímetro da panturrilha; crianças menores de 5 anos: apenas peso para idade.
- (C) Gestantes: IMC para idade cronológica e perímetro da cintura; adolescentes de 10 a 19 anos: IMC para idade gestacional; adultos: apenas IMC absoluto, sem relação com idade.
- (D) Crianças de 5 a 9 anos: IMC para idade, estatura para idade e peso para idade; adolescentes de 10 a 19 anos: IMC para idade e estatura para idade; adultos de 20 a 59 anos: IMC para idade e perímetro da cintura.

Questão 17. Uma Nutricionista de uma unidade básica de saúde está elaborando um grupo educativo para mulheres em diferentes fases do ciclo de vida. Durante uma reunião, surgiu a dúvida sobre estratégias nutricionais para aliviar sintomas de tensão pré-menstrual (TPM) e para promoção da saúde óssea e cardiovascular na menopausa. Considerando as evidências atuais, a orientação MAIS ADEQUADA para ser enfatizada às participantes é:

- (A) Recomendar eliminação total de carboidratos da dieta na TPM e na menopausa, priorizando dietas hiperproteicas como principal estratégia para controle de sintomas e prevenção de osteoporose e doenças cardiovasculares.
- (B) Explicar que, para o manejo da TPM e da menopausa, o mais importante é o controle medicamentoso, não havendo evidências suficientes para justificar mudanças na alimentação ou prática de exercícios físicos com foco em saúde óssea e cardiovascular.
- (C) Reforçar que, após o início da menopausa, a queda do estrogênio dispensa estratégias preventivas, pois o risco de osteoporose e doenças cardiovasculares está determinado principalmente por fatores genéticos, sendo pouco influenciado pelo estilo de vida.
- (D) Orientar uma alimentação rica em grãos integrais, frutas, vegetais, fontes de proteínas e laticínios magros, associada à ingestão adequada de cálcio, vitamina D, vitamina K e magnésio.

Questão 18. Em uma instituição de longa permanência para idosos a equipe de nutrição foi acionada para avaliar residentes com queixa de dificuldade para se alimentar, preferência por alimentos muito macios e redução da ingestão de frutas, vegetais frescos e carnes. Considerando as alterações orais e gastrointestinais comuns ao envelhecimento e suas repercussões nutricionais, a conduta nutricional MAIS ADEQUADA para favorecer a ingestão de nutrientes por esses idosos é:

- (A) Manter o cardápio padrão, apenas reduzindo o volume das refeições para evitar desconforto gástrico, uma vez que as alterações digestórias são esperadas para a idade e não impactam significativamente a ingestão de micronutrientes.
- (B) Priorizar preparações úmidas como sopas, guisados, alimentos picados ou em purê, junto a molhos para facilitar mastigação e deglutição, além de utilizar alimentos com maior densidade nutricional e ajustar a textura.
- (C) Substituir a maior parte das refeições por suplementos líquidos industrializados, já que a mastigação está prejudicada, dispensando a necessidade de adaptação de textura e de intervenções relacionadas ao ambiente ou prazer à mesa.
- (D) Restringir alimentos ricos em umidade e fibras para diminuir o risco de constipação intestinal típica da idade, priorizando alimentos secos e de baixa fermentação, sem necessidade de considerar a presença de xerostomia ou dentaduras mal adaptadas.

Questão 19. A microbiota intestinal participa ativamente da regulação de processos inflamatórios de baixo grau associados à obesidade, resistência à insulina e outras alterações cardiometabólicas. Sobre a relação entre dieta, microbiota intestinal e risco cardiometabólico, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Dietas ricas em gorduras saturadas e açúcares simples aumentam a diversidade bacteriana e fortalecem a camada de muco intestinal, reduzindo a translocação de LPS e a inflamação de baixo grau associada à obesidade.
- (B) A redução da *Akkermansia muciniphila*, a diminuição da camada de muco e a desestabilização das *tight junctions* induzidas por dieta rica em gordura favorecem a endotoxemia metabólica, enquanto a maior produção de Ácidos Graxos de Cadeia Curta (AGCC) a partir de fibras contribui para menor inflamação e melhor sensibilidade à insulina.
- (C) O aumento relativo de Firmicutes está inversamente associado à gordura corporal e à circunferência da cintura, e o consumo elevado de fibras perde totalmente seu efeito sobre a microbiota independentemente da presença de dieta rica em gordura.
- (D) A adesão à dieta Mediterrânea ou à dieta DASH não exerce influência relevante sobre a microbiota intestinal, sendo a composição bacteriana determinada quase exclusivamente por fatores genéticos, independentemente do padrão alimentar e da ingestão calórica.

Questão 20. A puberdade é o período de rápido crescimento e desenvolvimento durante o qual uma criança se desenvolve fisicamente até se tornar um adulto capaz de se reproduzir. É iniciada pelo aumento da produção dos hormônios reprodutivos, como estrogênio, progesterona e testosterona e caracteriza-se pelo aparecimento externo de características sexuais secundárias, como o desenvolvimento das mamas nas mulheres e o surgimento de pelos faciais nos homens. Sobre as necessidades nutricionais na adolescência, é CORRETO afirmar que:

- (A) Após o término do estirão de crescimento, as necessidades de cálcio caem para valores próximos aos da infância, tornando desnecessária a preocupação com ingestão de laticínios e outras fontes de cálcio na adolescência.
- (B) A ingestão de ferro em meninas permanece estável ao longo da adolescência, independentemente da ocorrência de menstruação, e a suplementação de ferro só é indicada em casos de anemia já instalada.
- (C) A Ingestão Diária Recomendada (RDA) de cálcio para adolescentes é de 1.300 mg/dia e a alta ingestão de refrigerantes pode contribuir para baixa ingestão de cálcio ao substituir o leite.
- (D) Os meninos adolescentes não apresentam aumento significativo das necessidades de ferro durante o estirão de crescimento e, portanto, não precisam se preocupar com o consumo de carnes, leguminosas e outros alimentos ricos em ferro.

Questão 21. Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF), assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a conduta recomendada para suplementação profilática de ferro e ácido fólico no contexto do cuidado nutricional na Atenção Básica.

- (A) Crianças de seis a 24 meses devem receber 1 mg de ferro elementar por kg de peso corporal diariamente até completar 24 meses, gestantes devem receber 40 mg de ferro elementar e 400 µg de ácido fólico diariamente durante toda a gestação.
- (B) O PNSF recomenda suplementação de ferro apenas para gestantes e crianças menores de seis meses, sendo que para crianças de seis a 24 meses a suplementação só deve ser feita após confirmação laboratorial de anemia.
- (C) Mulheres no pós-parto devem receber 40 mg de ferro elementar diariamente até o terceiro mês pós-parto. Para gestantes, a suplementação de ácido fólico deve ser iniciada apenas após o primeiro trimestre de gestação, pois antes desse período não há evidências de benefício para a prevenção de defeitos do tubo neural.
- (D) Mulheres no pós-parto não fazem parte do público-alvo do PNSF, pois o programa considera que a necessidade de ferro retorna ao padrão não gestacional imediatamente após o parto, não havendo indicação de suplementação nesse período.

Questão 22. Um Nutricionista de um ambulatório de geriatria está revisando a prescrição dietética de um idoso de 78 anos, com constipação intestinal frequente, baixa ingestão hídrica e uso de múltiplos medicamentos, mas com função renal preservada. Considerando as mudanças nutricionais típicas do envelhecimento e as recomendações atuais, o ajuste na orientação alimentar MAIS ADEQUADO para esse paciente é:

- (A) Reduzir a oferta de carboidratos complexos e fibras para evitar aumento do volume fecal, mantendo a ingestão hídrica em torno de 1.000 mL/dia para não sobrecarregar a função renal.
- (B) Manter a recomendação mínima de proteínas em 0,8 g/kg/dia para não elevar a carga renal, restringir lipídeos ao mínimo possível e não modificar a ingestão de água, pois a hidratação não interfere na constipação em idosos.
- (C) Aumentar gradualmente a ingestão de carboidratos ricos em fibras, como legumes, verduras, frutas e grãos integrais, associando incentivo à ingestão de líquidos de pelo menos 1.500 mL/dia, ajustando as porções à menor necessidade energética do idoso.
- (D) Priorizar suplementos proteicos para atingir 1,2 g/kg/dia prioritariamente aos alimentos, reduzir ao máximo a ingestão de frutas e vegetais e limitar a água a pequenos volumes para diminuir o risco de incontinência urinária.

Questão 23. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das principais estratégias de garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada no ambiente escolar, articulando oferta de refeições, promoção da saúde, Segurança Alimentar e Nutricional e Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

Considerando as atribuições do Nutricionista no PNAE, de acordo com a legislação e normas vigentes, a alternativa que descreve de forma MAIS ADEQUADA esse papel é:

- (A) Compete ao Nutricionista elaborar cardápios compatíveis com as referências nutricionais e com o perfil epidemiológico da clientela, realizar testes de aceitabilidade quando houver mudanças significativas nas preparações, orientar boas práticas de armazenamento e distribuição dos alimentos e participar do processo de compra, priorizando produtos com menor custo, ainda que isso implique menor aquisição de gêneros da agricultura familiar.
- (B) Entre as atribuições do Nutricionista estão o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional dos escolares, o planejamento de cardápios alinhados às faixas etárias e aos hábitos alimentares locais, a elaboração de fichas técnicas das preparações e a orientação da equipe de cozinha, sendo o relacionamento com agricultores familiares e o assessoramento ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) funções preferenciais, mas não previstas como responsabilidades técnicas específicas.
- (C) O Nutricionista responde tecnicamente pela alimentação escolar, devendo considerar o diagnóstico nutricional, os hábitos e a cultura alimentar da localidade na elaboração dos cardápios, planejar e supervisionar etapas de compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, desenvolver ações de EAN com a comunidade escolar e interagir com agricultores familiares e o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), sem descuidar das exigências de boas práticas sanitárias e dos parâmetros estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
- (D) A responsabilidade técnica do Nutricionista no PNAE concentra-se na elaboração de cardápios em conformidade com as metas de gasto definidas pelo gestor e na implantação do Manual de Boas Práticas, cabendo aos setores de compras e à direção escolar decidir sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar, a realização de ações de EAN e o registro dos resultados no Relatório Anual de Gestão.

Questão 24. A Lei nº 8080/90 regula as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado. Em relação a isso, assinale a alternativa que MELHOR EXPRESSA uma condição prevista para a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil.

- (A) A participação de capital estrangeiro é vedada em qualquer modalidade de serviço assistencial, sendo admitida apenas em atividades de ensino e pesquisa em saúde, desvinculadas da prestação de serviços ao usuário.
- (B) A participação de empresas ou de capital estrangeiro é permitida, entre outros casos, em pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospitais gerais e especializados, policlínicas e clínicas especializadas e ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que observadas as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (C) O ingresso de capital estrangeiro é permitido exclusivamente para manutenção de serviços de saúde próprios de empresas, voltados a empregados, com ou sem finalidade lucrativa, desde que haja contrapartida financeira da seguridade social na forma de subsídio.
- (D) A legislação admite a participação de capital estrangeiro apenas sob a forma de doações para aquisição de equipamentos, vedando sua atuação em gestão, operação ou controle de estabelecimentos assistenciais de saúde no território nacional.

Questão 25. A tireoide é uma pequena glândula em forma de borboleta, encontrada logo abaixo da proeminência laríngea. Embora pese menos de 30 g, ela produz hormônios que influenciam essencialmente todos os órgãos, tecidos e células do corpo, tendo um enorme efeito na saúde. Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA sobre fatores nutricionais relacionados ao hipotireoidismo e à tireoidite de Hashimoto.

- (A) A deficiência de iodo é a principal causa de hipotireoidismo em todo o mundo, mas na tireoidite de Hashimoto a suplementação indiscriminada de iodo pode piorar o quadro autoimune, pois aumenta a atividade da TPO e eleva títulos de ATPO.
- (B) O consumo de vegetais crucíferos é formalmente contraindicado em todas as pessoas com hipotireoidismo, independentemente do estado de iodo, pois seus glucosinolatos sempre levam à inibição clinicamente relevante da síntese de hormônios tireoidianos.
- (C) A soja não apresenta qualquer ação goitrogênica, mesmo em contextos de baixa ingestão de iodo, e por isso pode ser utilizada sem cautela em pacientes com disfunção tireoidiana, dispensando avaliação do estado de iodo.
- (D) O selênio participa apenas da defesa antioxidante via glutathione peroxidase, não interferindo na conversão periférica de T4 em T3, de modo que sua deficiência não se relaciona com alterações do perfil de hormônios tireoidianos.

Questão 26. Uma Nutricionista é convidada a orientar pais de crianças em idade pré-escolar que estão preocupados porque seus filhos “comiam bem quando eram bebês, mas agora recusam vários alimentos, querem sempre a mesma coisa e vivem pedindo suco de fruta no lugar de água ou leite”. Considerando o comportamento alimentar típico dessa faixa etária e os possíveis impactos do consumo excessivo de sucos, a orientação MAIS ADEQUADA é:

- (A) Explicar que a recusa de alimentos e as fixações alimentares indicam seletividade patológica, devendo-se insistir com firmeza para que a criança coma tudo o que é oferecido.
- (B) Esclarecer que a redução do apetite e as fases de recusa ou preferência repetitiva por determinados alimentos são comuns e transitórias, orientar os pais a evitarem brigas ou coerção na hora das refeições e recomendar limitar a oferta de sucos de frutas, priorizando água e leite como principais bebidas.
- (C) Orientar que os pais atendam prontamente aos pedidos repetidos para garantir a ingestão calórica mínima, associando a oferta de grandes quantidades de sucos às refeições para compensar a baixa aceitação.
- (D) Informar que o comportamento é inadequado e os pais devem restringir a autonomia da criança, definindo horários rígidos e substituindo a água por sucos de frutas, pois estes não trazem riscos digestivos.

Questão 27. Em uma consulta de pré-natal em um ambulatório de nutrição, uma gestante no segundo trimestre relata sensação frequente de falta de ar ao subir poucos lances de escada, leve edema em membros inferiores ao final do dia e episódios de azia e constipação intestinal. Os exames laboratoriais mostram discreta redução da hemoglobina e da albumina sérica, sem outros achados relevantes. Considerando as mudanças fisiológicas características da gestação e a atuação do Nutricionista, avalie as situações descritas e assinale a alternativa que apresenta a melhor interpretação e a conduta MAIS ADEQUADA.

- (A) A dispneia, o edema e a constipação são sinais de descompensação cardiovascular e renal, exigindo restrição hídrica, redução de fibras até normalização dos sintomas e aumento do aporte energético.
- (B) A redução da hemoglobina e albumina é sempre indicativa de deficiência nutricional grave, devendo ser imediatamente prescrita dieta hiperproteica e suplementação de ferro em altas doses.
- (C) A dispneia relaciona-se a maior demanda de oxigênio, o edema, da compressão da veia cava inferior e a constipação, ao aumento da progesterona, devendo aumentar o fracionamento de refeições, o consumo de fibras e líquidos e manejo dietético da azia.
- (D) A presença de glicosúria é imprescindível para explicar a constipação e a azia, sendo prioritário reduzir drasticamente a ingestão de carboidratos complexos e suspender o consumo de frutas ricas em fibras.

Questão 28. Uma Nutricionista atende uma puérpera de 12 dias pós-parto, em aleitamento materno exclusivo, que está preocupada porque sente que o leite está fraco, já que percebe o leite mais ralo e azulado no início das mamadas e o bebê solicita o peito com frequência. A mãe relata que costuma trocar o lado da mama após poucos minutos, assim que o bebê diminui o ritmo de sucção, para ele mamar dos dois peitos em todas as mamadas. Considerando os estágios do leite humano, as características do leite maduro (leite anterior e posterior) e a atuação da Nutricionista na orientação à nutriz, assinale a alternativa que apresenta a conduta MAIS ADEQUADA.

- (A) Explica que o leite mais ralo e azulado inicial é o colostro e que, por isso, é importante limitar o tempo de cada mamada a poucos minutos por mama, trocando rapidamente de lado.
- (B) Esclarecer que o leite mais ralo do início da mamada é o leite anterior, rico em água, proteínas e vitaminas hidrossolúveis, e que o leite posterior, mais cremoso e energético, é liberado com o esvaziamento da mama. Recomendar que o lactente esvazie a mama antes de oferecer a outra.
- (C) Orientar que a mãe ofereça sempre as duas mamas por tempo fixo de 5 minutos em cada lado, garantindo que o lactente receba apenas o leite anterior, evitando o posterior para não favorecer massa corporal.
- (D) Explicar que, após a segunda semana pós-parto, todo o leite produzido passa a ter composição homogênea durante a mamada, não havendo diferença entre leite anterior e posterior, e que a sensação de peito "mole" confirma redução irreversível da produção láctea.

Questão 29. Diversas intervenções não medicamentosas são sugeridas para a promoção da saúde, prevenção e controle da hipertensão arterial, tendo a mudança de estilo de vida um grande impacto no tratamento. Considerando esses aspectos fisiológicos, assinale a alternativa que descreve, CORRETAMENTE, a relação entre medidas dietéticas e o controle da pressão.

- (A) A perda de peso isolada reduz discretamente a pressão arterial e a circunferência abdominal deve ser mantida < 102 cm em homens e < 88 cm em mulheres mas a ingestão de sódio e potássio não altera significativamente os mecanismos hemodinâmicos, sendo a dieta relevante apenas para controle do peso corporal.
- (B) A moderação no consumo de álcool e de cafeína tem papel marginal na pressão arterial, de modo que mudanças no peso corporal, no sódio e no potássio só são relevantes em estágios muito avançados de hipertensão, sem impacto em fases iniciais da doença.
- (C) A restrição de sódio < 2 g/dia reduz a pressão arterial ao diminuir a retenção hídrica e o volume plasmático. O aumento do consumo de potássio dietético favorece vasodilatação e natriurese, potencializando a redução pressórica.
- (D) O sal de ervas é uma opção com menor sódio. Outros tipos de sal, como o sal marinho, apresentam menor teor de sódio que o sal de cozinha comum.

Questão 30. A Lei que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) define instâncias e atribuições específicas para garantir a formulação, execução, monitoramento e avaliação da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, envolvendo conferências, conselho, câmara interministerial, órgãos públicos e instituições privadas. Sobre a composição e o funcionamento dessas instâncias, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A Conferência Nacional é convocada diretamente pelos Ministérios setoriais, sem necessidade de instância própria, e sua realização não depende de conferências municipais, estaduais ou distrital.
- (B) O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) é composto majoritariamente por representantes do governo federal (2/3) e 1/3 por sociedade civil, sendo sua presidência obrigatoriamente exercida por um Ministro de Estado, designado pelo Presidente da República.
- (C) A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional tem entre suas atribuições elaborar, a partir das diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), a Política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
- (D) As instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, não podem integrar o SISAN, que se restringe a órgãos públicos federais, estaduais, distrital e municipais diretamente ligados à área de alimentação e nutrição.

Questão 31. Um município identifica, a partir dos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) e de inquéritos locais, aumento de excesso de peso em escolares e de anemia em gestantes, e decide qualificar a gestão das ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica. Nessa situação, a conduta que se alinha às atribuições do Nutricionista na subárea Atenção Básica em Saúde, no segmento Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição é:

- (A) Realizar atendimentos clínicos individuais nas unidades básicas, ausentando-se na definição de indicadores ou análise dos dados do SISVAN, pois essas funções são privativas ao gestor da Atenção Básica.
- (B) Executar atividades educativas pontuais, sem atribuição em processos de gestão como Programação Anual de Saúde (PAS), Relatório Anual de Gestão (RAG) ou pactuações em conselhos de saúde.
- (C) Delegar integralmente a análise dos dados do estado nutricional às equipes de saúde da família para que definam parâmetros técnicos e protocolos, evitando interferência nas decisões gerenciais da Secretaria.
- (D) Atuar no planejamento e coordenação das ações de alimentação e nutrição no município, participar da elaboração e monitoramento da Programação Anual de Saúde incluindo metas, indicadores e recursos para cuidado nutricional, coordenar e avaliar a implantação do SISVAN e propor ações frente aos riscos nutricionais identificados.

Questão 32. A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) busca promover a autonomia e o autocuidado por meio de abordagens problematizadoras, considerando o sistema alimentar e os aspectos socioculturais. Em relação a essa temática, assinale a alternativa que reflete, CORRETAMENTE, um desafio central para a efetivação da EAN no contexto das políticas públicas.

- (A) Garantir que as ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) sejam conduzidas prioritariamente por Nutricionistas, evitando a participação de outros profissionais e setores, para assegurar a precisão técnica das orientações alimentares.
- (B) Superar a tendência histórica de práticas prescritivas e biomédicas, promovendo metodologias que valorizem o diálogo, a escuta ativa, a contextualização sociocultural e a participação da comunidade no planejamento e avaliação das ações.
- (C) Priorizar campanhas de massa com mensagens padronizadas e unidirecionais, pois a uniformidade das informações é essencial para garantir a adesão da população a hábitos alimentares saudáveis.
- (D) Restringir o escopo da EAN ao ambiente escolar, onde é possível controlar o comportamento alimentar das crianças, já que é nessa fase em que há maior efetividade das ações.

Questão 33. A segurança alimentar e nutricional envolve o direito ao acesso regular a alimentos de qualidade, respeitando a diversidade cultural e sustentabilidade, por meio de políticas intersetoriais e participação social. Para sua efetivação, o Estado deve promover políticas interseoriais, descentralizadas, com participação social, monitoramento contínuo e articulação entre orçamento e gestão, além de estimular pesquisa e capacitação. Considerando esses princípios e diretrizes, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE um dos pilares da segurança alimentar e nutricional no contexto do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

- (A) O acesso à alimentação adequada depende apenas da disponibilidade física de alimentos, sendo a produção agrícola o único fator determinante para garantir a segurança alimentar da população.
- (B) A promoção da saúde, nutrição e alimentação da população, incluindo grupos vulneráveis, é um dos componentes essenciais da segurança alimentar e nutricional, que também deve considerar a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos.
- (C) A participação social é facultativa nas políticas de segurança alimentar e nutricional, pois a formulação e execução dessas políticas cabe exclusivamente ao poder público, sem necessidade de controle social.
- (D) O monitoramento da situação alimentar e nutricional deve ser realizado apenas por indicadores econômicos, dispensando o uso de dados de saúde, educação ou desenvolvimento humano para subsidiar a gestão das políticas públicas.

Questão 34. Os guias alimentares são instrumentos fundamentais de saúde pública porque traduzem evidências científicas complexas em orientações práticas, compreensíveis e aplicáveis no dia a dia da população. Com base nisso, assinale a alternativa que MELHOR EXPRESSA a diferença central entre a antiga pirâmide alimentar e o atual Guia Alimentar para a População Brasileira.

- (A) A pirâmide alimentar priorizava alimentos in natura e desencorajava totalmente o consumo de produtos industrializados, enquanto o Guia Alimentar passou a permitir a base da dieta em produtos ultraprocessados, desde que em quantidades moderadas.
- (B) A pirâmide alimentar enfatizava a distribuição de porções por grupos de alimentos classificados principalmente por composição de nutrientes, ao passo que o Guia Alimentar organiza as recomendações com base no grau de processamento dos alimentos, valorizando alimentos in natura e minimamente processados, o ato culinário e o contexto social das refeições.
- (C) Tanto a pirâmide alimentar quanto o Guia Alimentar utilizam a mesma lógica de grupos alimentares e porções, diferenciando-se apenas na atualização dos valores de referência de calorias e macronutrientes recomendados para a população brasileira.
- (D) A pirâmide alimentar considerava fortemente aspectos culturais, ambientais e de sistema alimentar, enquanto o Guia Alimentar optou por concentrar-se em tabelas de nutrientes e metas numéricas de ingestão diária, facilitando o cálculo de dietas padronizadas.

Questão 35. A Lei nº 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Considerando o texto da lei, assinale a alternativa que descreve, CORRETAMENTE, uma condição para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde a Estados, Municípios e Distrito Federal.

- (A) Para receberem recursos, os entes devem possuir Conselho de Saúde consultivo, sem caráter deliberativo, não sendo obrigatória a existência de Fundo de Saúde ou de plano de saúde.
- (B) A transferência automática exige apenas a instituição de Fundo de Saúde e relatórios de gestão, sendo facultativa a criação de Conselhos de Saúde e a elaboração de plano de saúde.
- (C) Para recebimento de recursos, a lei exige que os Conselhos de Saúde sejam compostos majoritariamente por representantes do governo, ficando a participação de usuários limitada a um terço das cadeiras.
- (D) O repasse regular e automático de recursos financeiros para ações e serviços de saúde está condicionado, entre outros requisitos, à existência de Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com representação paritária dos usuários em relação aos demais segmentos, plano de saúde, relatórios de gestão e previsão de contrapartida de recursos no orçamento.

Questão 36. O Guia Alimentar reconhece obstáculos à alimentação saudável, como a presença de ultraprocessados, publicidade agressiva, falta de tempo para cozinhar e desigualdades de acesso. Sobre os obstáculos à adoção de práticas alimentares saudáveis, assinale a alternativa que está MAIS ADEQUADA ao documento.

- (A) O Guia entende que os principais obstáculos residem no desconhecimento nutricional, de modo que estratégias centradas em contar calorias e ler rótulos são suficientes para superar as barreiras.
- (B) O Guia identifica entre os obstáculos centrais a onipresença de produtos ultraprocessados, a publicidade que os promove, a escassez de tempo e infraestrutura para cozinhar e as desigualdades de acesso a alimentos in natura, ressaltando que tais barreiras exigem ações que vão além da esfera individual.
- (C) Para o Guia, o maior obstáculo à alimentação adequada é a manutenção de práticas culinárias tradicionais ricas em preparações feitas em casa, que devem ser substituídas por versões industrializadas.
- (D) O Guia considera que a expansão de *fast-food* e a oferta de produtos prontos são tendências inevitáveis e neutras, cabendo ao indivíduo adaptar-se por meio de escolhas dentro do universo ultraprocessado.

Questão 37. Com base nas características de crescimento e desenvolvimento de neonatos e lactentes, analise as assertivas a seguir:

- I. Neonatos saudáveis podem perder em torno de 7% da massa corporal nos primeiros dias de vida, recuperando-a entre o 7º e o 10º dia; perdas superiores a 10% nesse período indicam necessidade de investigação da adequação da alimentação.
- II. A capacidade gástrica aumenta significativamente ao longo do primeiro ano, passando de cerca de 10–20 mL ao nascimento para aproximadamente 200 mL em 12 meses, o que contribui para espaçamento progressivo entre as mamadas.
- III. A atividade da lactase atinge níveis semelhantes aos de adultos ao nascimento, enquanto a amilase pancreática permanece baixa nos primeiros 6 meses, sendo parcialmente compensada pela atividade de amilase salivar e pela digestão colônica do amido.
- IV. A função renal do neonato é imatura, com menor capacidade de concentração urinária nas primeiras semanas, o que torna mais crítico o risco de desidratação em situações como diarreia ou uso de fórmulas infantis excessivamente concentradas.

Estão CORRETAS:

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) I, II, III e IV.

Questão 38. A terapia nutricional no diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é considerada componente central do tratamento em todas as fases da doença, contribuindo tanto para a prevenção da progressão do pré-diabetes quanto para o controle glicêmico e o sucesso da terapia farmacológica.

Com base nessas recomendações, assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, um conjunto de orientações condizentes com as diretrizes atuais de terapia nutricional no DM2.

- (A) Em pré-diabetes, recomenda-se consumo de fibras de pelo menos 25–30 g/dia por estar associado a menor risco de evolução para DM2, em pessoas com DM2 e sobrepeso ou obesidade recomenda-se perda de, no mínimo, 5% do peso corporal inicial para melhora do controle glicêmico, e em adultos com DM2 recomenda-se ingestão de fibras de 14 g/1000 kcal, com um mínimo de 25 g/dia, para ajudar na redução da hiperglicemia pós-prandial.
- (B) Em pré-diabetes, recomenda-se evitar o consumo de fibras, pois estas elevam a glicemia pós-prandial, em pessoas com DM2 e sobrepeso ou obesidade a perda de peso não tem impacto significativo no controle glicêmico, e em adultos com DM2 o uso de fibras acima de 10 g/dia não é recomendado por interferir na absorção de medicamentos.
- (C) Em pessoas com DM2 e função renal preservada, recomenda-se restringir a proteína a menos de 0,5 g/kg/dia para prevenir complicações renais, o consumo de bebidas açucaradas é aceitável desde que dentro do valor calórico total diário, e o aumento de fibras além de 20 g/dia não exerce efeito relevante sobre a hiperglicemia pós-prandial.
- (D) Em pré-diabetes, recomenda-se consumo de fibras inferior a 15 g/dia para evitar desconforto intestinal, em pessoas com DM2 e sobrepeso ou obesidade a meta de perda de peso é desnecessária, uma vez que a terapia farmacológica é suficiente, e em adultos com DM2 a ingestão de fibras deve ser evitada em refeições principais para não retardar a ação da insulina.

Questão 39. A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), atualmente denominada Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD) está fortemente associada a fatores da síndrome metabólica, como obesidade central, resistência à insulina, DM2 e dislipidemia. Mudanças no estilo de vida são fatores importantes no tratamento da MASLD e NASH (Esteatohepatite Não Alcoólica). Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, um conjunto de medidas nutricionais corretamente relacionadas à melhora da MASLD.

- (A) Perda de peso > a 7% do peso corporal para melhora da NASH, a adoção de dieta mediterrânea apenas se houver perda de peso concomitante, a ingestão elevada de bebidas adoçadas com açúcar para evitar hipoglicemia e o consumo moderado de álcool.
- (B) Perda de peso > a 7% do peso corporal para melhora da NASH, a adoção de dieta mediterrânea como estratégia para reduzir a esteatose hepática independentemente da perda de peso, a limitação de frutose em bebidas, a restrição de alimentos ultraprocessados e eliminação de álcool.
- (C) Perda de peso > 15% do peso corporal para qualquer benefício hepático, a adoção de dieta mediterrânea apenas em indivíduos sem obesidade, o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados ricos em fibras adicionadas e a liberação de bebidas adoçadas, desde que a ingestão calórica total seja mantida.
- (D) Perda de peso discreta < 3% do peso corporal, pois reduções maiores podem agravar a fibrose, o estímulo ao consumo de frutose na forma de sucos de fruta industrializados para compensar a restrição de gordura da dieta, e o uso liberal de álcool em doses sociais, pois não há evidências de impacto sobre a progressão da MASLD.

Questão 40. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) tem como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira. Com base nesse tema, analise as assertivas a seguir:

- I. Ao considerar a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, a PNAN propõe que o cuidado em alimentação e nutrição vá além da dimensão biológica, contemplando os valores, as relações sociais, a história de vida e os significados culturais atribuídos ao comer.
- II. O respeito à diversidade e à cultura alimentar, na PNAN, implica reconhecer e preservar apenas os hábitos alimentares tradicionais indígenas, considerando que influências de outros povos descaracterizam a identidade alimentar brasileira.
- III. O fortalecimento da autonomia nas escolhas alimentares pressupõe apoiar o indivíduo na compreensão crítica dos determinantes sociais e das pressões do mercado de alimentos, evitando tanto a omissão profissional quanto a prescrição autoritária de condutas dietéticas.
- IV. A PNAN entende a alimentação e nutrição como fenômenos determinados apenas por escolhas individuais, de modo que a articulação intersetorial é desejável, porém não é considerada condição necessária para a mudança do perfil epidemiológico relacionado à alimentação.

Estão CORRETAS:

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas III e IV.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas I e IV.